行为康复治疗中心游戏活动标准化对患者心理弹性及手眼协调能力的改善效果

高蕾

（吉林省神经精神病医院）

摘　要：【目的】分析行为康复治疗中心游戏活动标准化对患者的影响。【方法】纳入本次研究的样本对象的时间范围为：2024年2月至2025年10月，入组的样本对象为60例行为康复治疗中心患者，采用随机分配方式对患者进行分组处理，均分为研究组和常规组，各30例，分别对其提供标准化游戏活动、常规康复训练，对比两组患者的差异性。【结果】研究组患者的康复依从性更高（$p<0.05$）；研究组患者的生活质量更高（$p<0.05$）。【结论】行为康复治疗中心游戏活动标准化对患者的心理弹性以及手眼协调能力具有明显的改善作用，能够提升患者的生活质量，提高患者的依从性。

关键词：行为康复治疗中心；游戏活动标准化；心理弹性；手眼协调能力

0　引言

康复医学在于帮助恢复患者身心功能，提升患者的生活质量。行为障碍患者常面临心理与躯体的双重困境，在疾病的影响下，患者多表现为共情障碍，加之社会角色的转变，患者往往会出现不同程度的焦虑、抑郁等情绪，并且还会对患者的生活自主性造成严重的影响，加剧患者的心理负担[1]。在行为康复治疗中心，应做好对患者的干预。常规康复干预的应用存在一定的局限性，对患者的应用效果不佳。游戏活动标准化现已在康复领域得到了广泛的应用，这种方式的应用相对更注重娱乐性，调动患者参与到各项康复活动中，可以有效改善患者的病情状况，更利于患者的康复[2]。因此，本文深入研究行为康复治疗中心游戏活动标准化对患者的影响。现将有关情况总结如下。

1　资料与方法

1.1 资料

对本次研究涉及的样本对象进行收录的时间范围制定为如下区间：2024年2月至2025年10月，入组的样本对象制定为60例行为康复治疗中心患者，采用随机分配方式对患者进行分组处理，以研究组、常规组作为两组的命名，各30例。研究组：男/女比例为16/14；年龄：52~89岁，均值（74.23±1.57）岁。常规组：男/女比例15/15；年龄：53~88岁，均值（74.25±1.55）岁。两组的一般资料对比无意义（$p>0.05$）。

1.2 方法

1.2.1 常规组

由专业心理治疗师每周进行2次一对一心理疏导，每次45 min，通过倾听共情支持等方式缓解患者负面情绪；手眼协调功能训练，采用传统的康复

作者简介：高蕾，本科，主管护师，研究方向为康复护理。

训练方法，如串珠子、搭积木、夹豆子等，每周训练5次，每次60 min，根据患者的功能水平调整训练难度；健康宣教，每周开展1次康复知识讲座，向患者及家属普及疾病康复相关知识，提升患者的康复认知。干预周期为12周。

1.2.2 研究组

（1）活动设计：依据患者的基础功能水平，将游戏活动分为基础级、进阶级与提升级三个梯度，每个梯度包含3~4种游戏，逐步提升训练难度。基础级游戏适用于手眼协调能力较差、心理弹性较低的患者，包括数字配对游戏、简单拼图游戏（4~8片）、抛接球游戏（大球）；进阶级游戏适用于具备一定手眼协调能力及心理适应能力的患者，包括图形分类游戏、中等难度拼图（12~24片）、夹乒乓球游戏、弹珠入洞游戏；提升级游戏适用于手眼协调能力及心理状态较好的患者，包括复杂拼图（36~60片）、套圈游戏（小圈）、穿线板游戏（细孔）、趣味投篮游戏（小篮筐）。

（2）实施流程：每周训练5次，每次90 min，其中常规康复训练60 min，标准化游戏活动30 min，干预周期为12周。每次游戏活动前，治疗师向患者讲解游戏规则及注意事项，根据患者的当前功能水平选择对应梯度的游戏；活动过程中，治疗师密切观察患者的表现，及时给予指导与鼓励，对于完成较好的患者给予口头表扬或小奖品奖励，对于遇到困难的患者进行耐心引导，帮助其分析问题并解决，避免患者产生挫败感；活动结束后，组织患者进行简短交流，分享游戏过程中的感受与经验，强化患者的积极体验。

1.3 观察指标

（1）两组手眼协调能力对比：采用九孔柱测试、数字划消测试对患者的手眼协调能力进行评估。

（2）两组患者的康复依从性对比：完全依从、部分依从。不依从等3个等级。

（3）两组患者的生活质量对比：心理功能、社会功能、躯体功能、认知功能等4个维度。

1.4 统计学分析

采用SPSS 26.0软件分析数据。计量资料以均数±标准差（$\bar{x} \pm s$）表示，组间比较采用独立样本t检验；计数资料以率（%）表示，组间比较采用χ^2检验或Fisher精确概率法；重复测量数据采用广义估计方程（GEE）分析时间效应。$p<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的手眼协调能力对比

研究组手眼协调能力更高（$p<0.05$），详情见表1。

2.2 两组患者的康复依从性对比

研究组患者的康复依从性更高（$p<0.05$），详情见表2。

2.3 两组患者的生活质量对比

研究组患者的生活质量更高（$p<0.05$），详情见表3。

表1 两组患者的手眼协调能力对比（$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	九孔柱测试完成时间/s		数字划消测试正确率/%	
		干预前	干预后	干预前	干预后
研究组	30	78.52±1.15	42.52±1.05	62.59±1.11	85.69±1.35
常规组	30	78.55±1.69	59.63±1.18	62.51±1.14	75.52±1.09
t值		0.080	59.331	0.275	32.103
p值		0.936	0.000	0.784	0.000

表2 两组患者的康复依从性对比[n（%）]

组别	例数	完全依从	部分依从	不依从	总依从性
研究组	30	18（60.00）	11（36.66）	1（3.33）	29（96.66）
常规组	30	15（50.00）	9（30.00）	6（20.00）	24（80.00）
χ^2值	–	0.606	0.300	4.043	4.043
p值	–	0.436	0.583	0.044	0.044

表3 两组患者的生活质量对比（$\overline{x}\pm s$）

组别	例数	心理功能		躯体功能		认知功能		社会功能	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
研究组	30	58.96±1.06	98.56±0.05	48.52±1.36	97.52±1.03	44.56±1.36	95.23±1.54	58.66±1.36	95.66±0.25
常规组	30	58.99±1.05	90.52±1.25	48.55±1.33	91.55±1.63	44.55±1.35	92.66±1.06	58.42±1.65	92.66±0.24
t值		0.110	35.201	0.086	16.958	0.028	7.529	0.614	47.414
p值		0.912	0.000	0.931	0.000	0.977	0.000	0.541	0.000

3 讨论

行为障碍患者的康复是一个涉及心理与躯体的系统工程，心理弹性的提升与手眼协调能力的改善相互促进，共同推动患者的康复进程[3]。心理弹性作为个体应对逆境的重要心理资源，其水平的高低直接影响患者康复的积极性与持续性。传统的心理干预多以语言疏导为主，形式单一，患者易产生抵触情绪。而标准化游戏活动通过趣味化的场景设计，让患者在轻松愉悦的氛围中参与康复过程。在游戏中，患者需要面对不同的挑战，通过自身的努力完成任务，这一过程能够逐步提升患者的自信心与自我效能感[4]。同时，治疗师的及时鼓励与奖励机制，能够强化患者的积极行为，帮助其建立乐观的心态，进而增强心理弹性。标准化游戏活动根据患者的功能水平设计阶梯式的训练方案，从简单的数字配对、抛接球游戏到复杂的拼图、穿线板游戏，逐步提升训练难度，既符合患者的功能恢复规律，又能保持患者的参与兴趣[5]。本次研究结果表明，研究组手眼协调能力更高（$p<0.05$）；研究组患者的康复依从性更高（$p<0.05$）；研究组患者的生活质量更高（$p<0.05$）。

综上所述，对于行为康复治疗中心的患者而言，给予其标准化游戏进行干预，这种方式的应用可以对患者的心理弹性具有积极的改善作用，并且能够纠正患者的手眼协调能力，提升患者的康复依从性，对患者的生活质量具有提高作用。

参考文献

[1] 李云雁,高俊平,李素萍,等.基于认知—情绪—行为的护理干预对青少年抑郁障碍伴拒绝上学行为患者的影响[J].心理月刊,2025,20(19):100-102,106.

[2] 王雪,刘秀蓉.基于积极心理学模式的护理干预对精神分裂症患者的应用[J].心理月刊,2025,20(19):146-148.

[3] 赵娜,马永嘉,李欣晔.合理情绪护理联合重复经颅磁刺激对双相情感障碍患者的影响[J].心理月刊,2025,20(17):185-187.

[4] 杨颖,王晓丽,宁珂.认知领悟疗法对双相情感障碍患者治疗依从性和自尊水平的影响分析[J].心理月刊,2025,20(13):179-181.

[5] 曾佩程,蒋文华,蒋智华,等.认知行为疗法、耳穴揿针联合睡眠护理在抑郁症伴失眠患者中的效果分析[J].护理实践与研究,2025,22(4):480-484.